

ARTROCENTESIS

Nuria Martínez Cao, Alba Gallego Gallego, Mari Cruz Pérez Panizo

INDICACIONES

Consiste en la aspiración de líquido sinovial de una articulación con aguja con dos principales indicaciones:

- **Artrocentesis diagnóstica** (análisis del líquido) o
- **Artrocentesis terapéutica** (alivio de la presión intraarticular, administración de fármacos) o la combinación de ambas.

La artrocentesis y el análisis del líquido sinovial son importantes en la evaluación de un paciente con signos de derrame articular y/o signos que sugieran inflamación de la articulación.

Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales pueden someterse a esta técnica de manera segura. El riesgo de hemartrosis iatrogénica en este tipo de pacientes es extremadamente bajo.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas: no existen

Relativas:

- Diátesis hemorrágica activa
- Infección de la piel en el lugar de la punción.
- Trastornos de la coagulación con plaquetopenia $<50000/\mu\text{l}$ entre otras.
- Falta de diagnóstico preciso
- Infiltraciones previas ineficientes
- Poliartritis

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Para realizar la artrocentesis se debe tener en cuenta: adecuada elección del tamaño de la aguja y jeringa, la esterilización de la piel y la anestesia local.

En determinadas situaciones puede ser útil la guía a través de una prueba de imagen (ecografía) al aspirar ciertas articulaciones de difícil acceso como la articulación de la cadera.

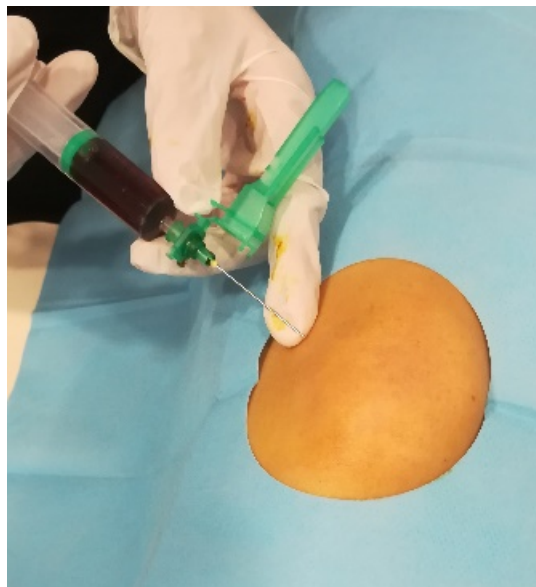
Procedimiento

La punción se realizará en decúbito supino y en condiciones de asepsia. El abordaje se puede hacer desde diferentes puntos o vías, debiendo utilizarse aquél con el que el clínico se encuentre más familiarizado, cómodo y seguro.

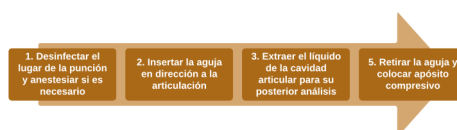
- Desinfectar el lugar de la punción con antiséptico y dejar secar al menos 5 minutos. La anestesia no siempre es necesaria, aunque al utilizar una aguja de gran calibre y en personas que refieran dolor, se puede anestesiar con solución de lidocaína al 1 %.



- Esperar 5 minutos tras infiltrar el anestésico. Insertar en el mismo punto la aguja conectada con la jeringa. Penetrar con la aguja en dirección a la articulación hasta sentir resistencia, lo que indica que el extremo de la aguja se encuentra en la cavidad articular, momento en el que se debe iniciar el aspirado del líquido. Extraer todo el líquido posible de la cavidad articular.



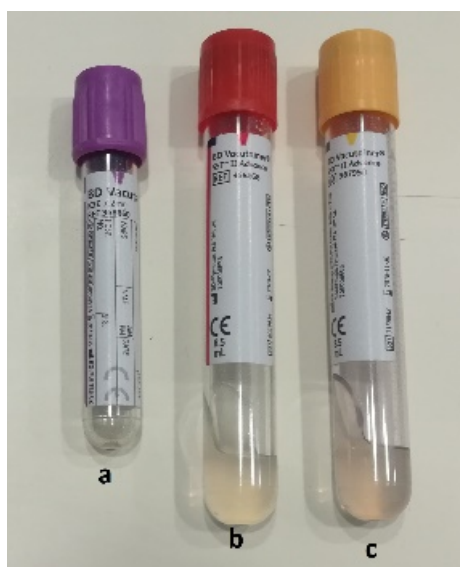
- Instilar el líquido en los tubos previamente preparados para enviar a laboratorio y colocar una gota en el portaobjetos.
- Opcionalmente, después de verter el líquido se pueden inyectar fármacos en la cavidad articular sin cambiar de aguja.
- Finalmente extraer la aguja, desinfectar el lugar de la punción y colocar un apósito compresivo estéril.



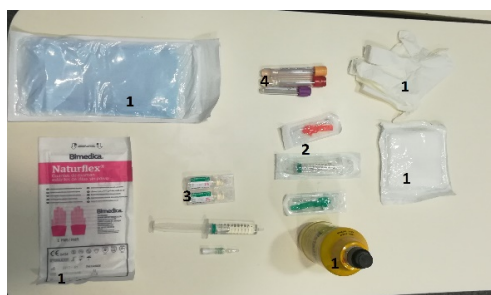
MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

- Equipo para preparar el campo: bata estéril, guantes estériles, gasas estériles, paños

- estériles, solución para el lavado, antiséptico (povidona yodada o clorhexidina).[1]
- Aguja (Ø 0,8 mm [21 G] o 1,2 mm [18 G]-verde-), jeringas estériles (1, 2, 5 y 10 ml) sin anticoagulante, materiales de apósito.[2]
- Anestésico local: solución de lidocaína al 1%.[3]
- Tubos de plástico con capacidad de 10 ml cerrados con tapones [4]:
 - Tubo sin aditivos (tapón violeta): para la visualización de cristales. [a]
 - Tubo heparinizado o con EDTA (rosa): para el recuento celular. [b]
 - Tubos estériles para microbiología (azul [cultivos aerobios], rojo [cultivos anaerobios]).
 - Tubo de bioquímica (tapón verde).
 - Tubos estériles secos para cultivo del líquido articular. [c]
- Si la cantidad es escasa, priorizar los cristales, recuento celular y cultivos (a, b y c).



- Portaobjetos de vidrio para microscopio y cubreobjetos desengrasados con alcohol.



COMPLICACIONES

- En condiciones estrictas de asepsia las complicaciones de infección local o articular son escasas.
- Dolor local que cede de forma habitual en las primeras 24h con analgésicos básicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Cristina Calvo, M Paz Collado, Rafael Díaz-Delgado. Artrocentesis e infiltración intraarticular. An Pediatr Contin. 2006;4(5):316-9.
- J.Vidal Fuentes. Indicaciones de la artrocentesis y análisis del líquido sinovial**. Medicine-

Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. Marzo 2005^{**}; 9(28):1849-51.

- Vicente Giner Ruiz, José Sanfélix Genovés. Artrocentesis de la rodilla. Formación Médica Continuada en Atención Primaria. Enero 2008; 15(1): 30-33.